



MARGINA

PARTNER-READY PACK · FR / EN

Décider à la marge qui compte.

Positionnement, plateforme, preuve, partenariats et identité de marque pour une couche de décision peropératoire fondée sur un jumeau numérique patient-spécifique.

Résumé partenaire

MARGINA en une phrase

Une couche de décision peropératoire qui fusionne imagerie, cartographie, physiologie et trajectoires pour présenter des options bornées — arrêter, mesurer ou poursuivre — avec une incertitude explicite.

Première indication

Décision au deep motor margin pendant la résection d'un gliome moteur-éloquent, sans remplacer la stimulation directe, les MEP, la navigation ou l'autorité du chirurgien.

Différenciation

Mise à jour peropératoire, prévision conditionnée par l'action, seuils de confiance, abstention et repli immédiat vers la pratique standard.

Modèle commercial envisagé

Licence institutionnelle ou par procédure, intégration, formation et partenariats avec fabricants de navigation, échographie et systèmes du bloc numérique.

Relation NEXYTAL

MARGINA est présentée comme une société d'innovation distincte au sein de NEXYTAL Groupe, avec sa propre discipline produit et de preuve.

Pourquoi maintenant

- La déformation peropératoire réduit la fiabilité d'un modèle préopératoire statique.
- Les signaux utiles existent, mais restent dispersés au moment de la décision.
- L'adoption de l'IA clinique exige transparence, surveillance humaine, validation externe et gestion du changement.

Document stratégique et de recherche. Ne pas utiliser pour les soins, une décision clinique en direct ou comme preuve d'autorisation réglementaire.

Plateforme et architecture de preuve

01 · SYNCHRONISER

État multimodal

IRM, tractographie, échographie 3D, cartographie, MEP, physiologie, trajectoires et phase opératoire.

02 · ACTUALISER

Jumeau numérique

Estimation de la relation évolutive entre tumeur, cavité, voie motrice et instruments.

03 · COMPARER

Actions bornées

Projection du bénéfice, du risque, de la fraîcheur des données et de l'incertitude.

Tableau de preuve pilote

72%*

Décisions documentées

88%*

Synchronisation réussie

64%*

Abstention appropriée

55%*

Adoption équipe

Lecture obligatoire

Ces valeurs illustrent la structure du tableau de bord. Elles ne sont ni des résultats d'étude, ni des performances cliniques, ni des engagements contractuels.

Avant publication : verrouiller les définitions, dénominateurs, fenêtres temporelles, contrôles qualité, responsables d'approbation et sources.

Portes de validation

Architecture du twin

PRÊT POUR ÉVALUATION

Étude silencieuse

EN REVUE

Validation externe

À PLANIFIER

Accord partenaire clinique

REQUIS

Autorisation de communication

NON ACCORDÉE

Partenariat, déploiement et marque

Partenaires recherchés

- Centres de neuro-oncologie et réseaux régionaux qualifiés
- Fabricants d'échographie et de navigation
- Neurophysiologie, suivi d'instruments et systèmes du bloc numérique
- Human factors, essais multicentriques, réglementation et économie de la santé

Cadre de collaboration

- Interfaces techniques et données nécessaires
- Frontières de propriété intellectuelle et publication
- Rôles d'approbation clinique, qualité et communication
- Critères d'arrêt, de repli et de surveillance

IDENTITÉ



MARGINA

Le croisement exprime une frontière active et un point de décision. L'identité évite les clichés du cerveau, du casque VR et de l'IA abstraite.



Typographie : Inter. Ton : précis, sobre, crédible, sans promesse excessive.

Prochaine étape proposée

Un atelier de 45 minutes pour confirmer le cas d'usage, les interfaces, les données, le rôle du partenaire et la porte de validation suivante.



MARGINA

ENGLISH SECTION

Make the right call at the margin that matters.

Positioning, platform, evidence, partnerships and brand identity for an intraoperative decision layer built on a patient-specific digital twin.

Partner summary

MARGINA in one sentence

An intraoperative decision layer that combines imaging, mapping, physiology and trajectories to present bounded options — stop, measure or extend — with uncertainty made explicit.

First indication

Deep motor margin decisions during motor-eloquent glioma surgery, without replacing direct stimulation, MEPs, navigation or surgeon authority.

Differentiation

Intraoperative updating, action-conditioned forecasts, confidence release gates, explicit abstention and immediate standard-practice fallback.

Proposed commercial model

Institutional or per-procedure licensing, integration, training, and partnerships with navigation, ultrasound and digital-OR vendors.

NEXYTAL relationship

MARGINA is positioned as a distinct innovation company within NEXYTAL Groupe, with its own product and evidence discipline.

Why now

- Intraoperative deformation reduces the reliability of static preoperative models.
- Useful signals exist, but remain fragmented at the decision point.
- Clinical AI adoption requires transparency, human oversight, external validation and controlled change.

Strategy and research material only. Not for patient care, live clinical decision-making, or evidence of regulatory authorization.

Platform and evidence architecture

01 · SYNCHRONIZE

Multimodal state

MRI, tractography, 3D ultrasound, mapping, MEPs, physiology, trajectories and operative phase.

02 · UPDATE

Digital twin

Estimate the changing relationship between tumor, cavity, motor pathway and instruments.

03 · COMPARE

Bounded actions

Project expected benefit, risk, data freshness and uncertainty.

Pilot proof dashboard

72%*

Decisions documented

88%*

Successful synchronization

64%*

Appropriate abstention

55%*

Team adoption

Required interpretation

These values demonstrate dashboard structure. They are not study results, clinical performance claims, or contractual commitments.

Before publication, lock definitions, denominators, time windows, quality controls, approval owners and source records.

Validation gates

Twin architecture

READY FOR EVALUATION

Silent-mode study

IN REVIEW

External validation

TO SCHEDULE

Clinical partner approval

REQUIRED

Communications approval

NOT APPROVED

Partnership, deployment and brand

Partners sought

- Qualified neuro-oncology centers and regional networks
- Ultrasound and navigation manufacturers
- Neurophysiology, instrument tracking and digital-OR systems
- Human factors, multicenter trials, regulatory strategy and health economics

Collaboration framework

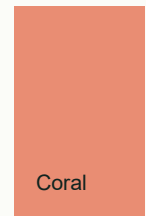
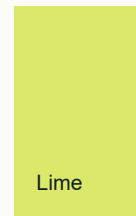
- Technical interfaces and required data
- Intellectual-property and publication boundaries
- Clinical, quality and communications approval roles
- Stop, fallback and monitoring criteria

IDENTITY



MARGINA

The crossing mark expresses an active boundary and decision point. The identity avoids brain, VR-headset and abstract-AI clichés.



Typography: Inter. Voice: precise, calm and credible, without exaggerated claims.

Proposed next step

A 45-minute working session to confirm the use case, interfaces, data, partner role and next validation gate.